# 第110回看護師国家試験（2021年実施）　眼科に関連する問題と解説

収録10問（直接眼科0・関連領域3・弱い関連7）。実施日：令和3年2月14日。作成日：2026-10-19。

各問を「問題文・全選択肢（原文）」「選択肢別の判定・解説」「公式正答」の順に掲載します。正答は厚生労働省の正答表に基づきます。解説は独自に作成した学習用原稿で、公式解説ではありません。「誤っているもの」を選ぶ問題では、誤った記述が正答です。

出典：厚生労働省ホームページ「第110回看護師国家試験の問題および正答について」https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp210416-03_04_05.html（2026-10-19利用）。読み仮名・改行・字間を整理し、英語病名の併記を省略したうえで学習用解説を追加した編集物です。図・写真は転載していません。Webサイト：https://adash333.github.io/nurse-ganka/r/

## 問題一覧

| 問題ID | 区分 | 分類 | テーマ | 公式正答 |
|---|---|---|---|---|
| 110A11 | 必修 | 弱い関連 | 後頭葉（視覚野） | 2 |
| 110A44 | 一般 | 関連領域 | 皮膚・眼瞼結膜の紅斑と水疱（SJS） | 4 |
| 110A54 | 一般 | 弱い関連 | ネフローゼ症候群（眼瞼浮腫） | 4 |
| 110A90 | 一般 | 弱い関連 | 身体的フレイル（視力低下の選択肢） | 2・4 |
| 110A94 | 状況設定 | 弱い関連 | 骨髄穿刺後の観察（眼瞼結膜） | 2 |
| 110B19 | 必修 | 弱い関連 | 触診で判断する所見（瞳孔反射の選択肢） | 4 |
| 110B21 | 必修 | 弱い関連 | 空気感染予防の個人防護具（フェイスシールド） | 2 |
| 110B62 | 一般 | 関連領域 | 眼球運動障害を伴う脳症 | 3 |
| 110B82 | 一般 | 関連領域 | 副交感神経を含む脳神経（動眼神経） | 1・4 |
| 110B116 | 状況設定 | 弱い関連 | NPPV使用者の観察（眼の充血） | 1 |

## 110A11　後頭葉（視覚野）

区分：必修／分類：弱い関連／主題：大脳の機能局在と視覚／出典：午前問題PDF 9ページ

後頭葉にあるのはどれか。

1　嗅覚野
2　視覚野
3　聴覚野
4　体性感覚野

### 解説

| 選択肢 | 判定 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 誤答 | 嗅覚野は側頭葉内側。 |
| 2 | 正答 | 視覚野は後頭葉の鳥距溝周囲にあり、障害で反対側の同名半盲が起こる。 |
| 3 | 誤答 | 聴覚野は側頭葉。 |
| 4 | 誤答 | 体性感覚野は頭頂葉中心後回。 |

**公式正答：2　視覚野**

## 110A44　皮膚・眼瞼結膜の紅斑と水疱（SJS）

区分：一般／分類：関連領域／主題：全身疾患と眼（Stevens-Johnson症候群）／出典：午前問題PDF 18ページ

A さん（64歳、男性）は、肺炎のため抗菌薬の投与目的で入院となった。治療開始後3日に全身の皮膚、眼瞼結膜および口腔粘膜に紅斑と水疱が出現した。バイタルサインは、体温38.5℃、呼吸数24/分、脈拍80/分、血圧124/80mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉96%（room air）であった。A さんに出現している症状から考えられる病態はどれか。

1　後天性表皮水疱症
2　Sjögren〈シェーグレン〉症候群
3　全身性エリテマトーデス
4　Stevens-Johnson〈スティーブンス・ジョンソン〉症候群

### 解説

| 選択肢 | 判定 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 誤答 | 後天性表皮水疱症は自己免疫性で、発熱や急性の粘膜疹は典型的でない。 |
| 2 | 誤答 | Sjögren症候群は乾燥症状が主。 |
| 3 | 誤答 | 全身性エリテマトーデスでは蝶形紅斑などで、抗菌薬投与後の急性の水疱・粘膜疹は典型的でない。 |
| 4 | 正答 | 薬剤やマイコプラズマ感染を契機に高熱、全身の紅斑・水疱・びらん、眼・口腔・外陰部の粘膜病変を起こす。 |

**公式正答：4　Stevens-Johnson〈スティーブンス・ジョンソン〉症候群**

**ポイント**：SJSでは急性期に偽膜性結膜炎や角膜上皮障害が起こり、慢性期に瞼球癒着、睫毛乱生、重度のドライアイ、視力障害を残す。発症早期からの眼科受診が後遺症を左右する。

**整理**：薬疹で「眼が赤い・痛い」「口内炎」があれば重症薬疹を疑い直ちに報告する。

## 110A54　ネフローゼ症候群（眼瞼浮腫）

区分：一般／分類：弱い関連／主題：全身疾患と眼（腎炎の眼瞼浮腫）／出典：午前問題PDF 22ページ

A ちゃん（11歳、女児）は、5日前から両側の眼瞼浮腫と急な体重増加があり、尿量が少ないため来院した。高度の蛋白尿もみられたため入院し、ネフローゼ症候群と診断されステロイド治療の方針となった。現時点でのA ちゃんへの看護で適切なのはどれか。

1　水分摂取を促す。
2　病院内を散歩して良いと伝える。
3　糖分の摂取制限があることを伝える。
4　一時的に満月様顔貌になることを説明する。

### 解説

| 選択肢 | 判定 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 誤答 | 浮腫と乏尿があり水分は制限する。 |
| 2 | 誤答 | 高度蛋白尿の時期は安静が必要。 |
| 3 | 誤答 | 糖分ではなく塩分を制限する。 |
| 4 | 正答 | ステロイドの副作用（満月様顔貌、食欲亢進、易感染）を年齢に合わせて説明する。 |

**公式正答：4　一時的に満月様顔貌になることを説明する。**

**ポイント**：眼瞼は皮下組織が疎で浮腫が出やすく、朝の眼瞼浮腫は腎性浮腫の典型。

## 110A90　身体的フレイル（視力低下の選択肢）

区分：一般／分類：弱い関連／主題：高齢者の評価と視力／出典：午前問題PDF 33ページ

身体的フレイルの評価基準はどれか。2つ選べ。

1　視力低下
2　体重減少
3　聴力低下
4　歩行速度の低下
5　腸蠕動運動の低下

### 解説

| 選択肢 | 判定 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 誤答 | 視力低下はフレイルの評価基準に含まれないが、転倒や活動低下を介してフレイルに影響する。 |
| 2 | 正答 | 意図しない体重減少は基準の一つ。 |
| 3 | 誤答 | 聴力低下は基準に含まれない。 |
| 4 | 正答 | 歩行速度の低下は基準の一つ。 |
| 5 | 誤答 | 腸蠕動は無関係。 |

**公式正答：2　体重減少、4　歩行速度の低下**

**ポイント**：白内障や視野障害は活動範囲を狭め、フレイルや認知機能低下の危険因子になる。

## 110A94　骨髄穿刺後の観察（眼瞼結膜）

区分：状況設定／分類：弱い関連／主題：貧血と眼瞼結膜／出典：午前問題PDF 36ページ

> 【状況設定文】A さん（26歳、男性）は1か月前から動悸と20m程度の歩行でも息切れが出現するようになった。ぶつけた記憶もないのに下肢に出血斑ができるようになり、医療機関を受診した。A さんは急性白血病を疑われ、緊急入院し、後腸骨稜から骨髄穿刺を受けた。身体所見：意識清明、体温37.2℃、呼吸数17/分、脈拍124/分、血圧96/52mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉97%（room air）、両下肢に散在する出血斑あり。検査所見：Hb 5.1g/dL、白血球44,960/μL、血小板1.5万/μL、総ビリルビン1.1mg/dL、尿素窒素19.4mg/dL、クレアチニン0.76mg/dL、CRP 2.2mg/dL。胸部エックス線：縦郭・心陰影・肺野に異常なし。

A さんの骨髄穿刺の30分後に観察すべき項目で優先度が高いのはどれか。

1　経皮的動脈血酸素飽和度
2　穿刺部の止血状態
3　下肢の運動障害
4　眼瞼結膜

### 解説

| 選択肢 | 判定 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 誤答 | 呼吸状態に問題はなく優先度は低い。 |
| 2 | 正答 | 血小板減少があり、穿刺部からの出血・血腫を30分後に確認する。 |
| 3 | 誤答 | 後腸骨稜からの穿刺で下肢の運動障害は起こりにくい。 |
| 4 | 誤答 | 眼瞼結膜の蒼白は貧血の観察項目だが、Hb 5.1g/dLと既に分かっており、穿刺後の優先観察ではない。 |

**公式正答：2　穿刺部の止血状態**

**ポイント**：眼瞼結膜の色は貧血の簡便な観察法。黄染は眼球結膜で見る。

## 110B19　触診で判断する所見（瞳孔反射の選択肢）

区分：必修／分類：弱い関連／主題：フィジカルアセスメントと瞳孔／出典：午後問題PDF 12ページ

フィジカルアセスメントにおいて触診で有無を判断するのはどれか。

1　腱反射
2　瞳孔反射
3　腸蠕動運動
4　リンパ節の腫脹

### 解説

| 選択肢 | 判定 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 誤答 | 腱反射は打診器で誘発する。 |
| 2 | 誤答 | 瞳孔反射（対光反射）はペンライトを当てて瞳孔の収縮を視診で確認する。 |
| 3 | 誤答 | 腸蠕動運動は聴診。 |
| 4 | 正答 | リンパ節は指で触れて大きさ・硬さ・可動性・圧痛を判断する。 |

**公式正答：4　リンパ節の腫脹**

**ポイント**：瞳孔の観察は、自然光下での大きさと左右差、直接・間接対光反射の順に行う。

## 110B21　空気感染予防の個人防護具（フェイスシールド）

区分：必修／分類：弱い関連／主題：個人防護具と眼の防護／出典：午後問題PDF 12ページ

空気感染を予防するための医療者の個人防護具で適切なのはどれか。

1　手袋
2　N95マスク
3　シューズカバー
4　フェイスシールド

### 解説

| 選択肢 | 判定 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 誤答 | 手袋は接触・標準予防策。 |
| 2 | 正答 | 空気感染（結核、麻疹、水痘）ではN95マスクを着用し、陰圧室で管理する。 |
| 3 | 誤答 | シューズカバーは通常不要。 |
| 4 | 誤答 | フェイスシールドは飛沫感染対策や血液飛散時の眼の防護に使う。 |

**公式正答：2　N95マスク**

**ポイント**：眼の粘膜は飛沫感染（インフルエンザ、アデノウイルス）の侵入門戸でもある。

## 110B62　眼球運動障害を伴う脳症

区分：一般／分類：関連領域／主題：全身疾患と眼（Wernicke脳症）／出典：午後問題PDF 25ページ

アルコールを多飲する人によくみられ、意識障害、眼球運動障害および歩行障害を特徴とするのはどれか。

1　肝性脳症
2　ペラグラ
3　Wernicke〈ウェルニッケ〉脳症
4　Creutzfeldt-Jakob〈クロイツフェルト・ヤコブ〉病

### 解説

| 選択肢 | 判定 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 誤答 | 肝性脳症では羽ばたき振戦が特徴で、眼球運動障害は典型的でない。 |
| 2 | 誤答 | ペラグラはナイアシン欠乏で皮膚炎・下痢・認知症。 |
| 3 | 正答 | アルコール多飲者のビタミンB1欠乏で発症し、外眼筋麻痺・眼振・意識障害・失調を示す。ブドウ糖投与前にビタミンB1を補う。 |
| 4 | 誤答 | Creutzfeldt-Jakob病は急速進行する認知症とミオクローヌス。 |

**公式正答：3　Wernicke〈ウェルニッケ〉脳症**

**ポイント**：眼球運動障害は外転神経麻痺や注視麻痺、眼振として現れる。

## 110B82　副交感神経を含む脳神経（動眼神経）

区分：一般／分類：関連領域／主題：脳神経と眼（対光反射・眼球運動）／出典：午後問題PDF 32ページ

副交感神経を含む脳神経はどれか。2つ選べ。

1　動眼神経
2　三叉神経
3　内耳神経
4　迷走神経
5　舌下神経

### 解説

| 選択肢 | 判定 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 正答 | 動眼神経はEdinger-Westphal核からの副交感線維を含み、瞳孔括約筋と毛様体筋を支配する。 |
| 2 | 誤答 | 三叉神経は知覚と咀嚼筋の運動。 |
| 3 | 誤答 | 内耳神経は聴覚・平衡覚の感覚神経。 |
| 4 | 正答 | 迷走神経は胸腹部臓器に副交感線維を送る。 |
| 5 | 誤答 | 舌下神経は舌の運動神経。 |

**公式正答：1　動眼神経、4　迷走神経**

**ポイント**：顔面神経の副交感線維は涙腺・顎下腺・舌下腺の分泌を促す。

## 110B116　NPPV使用者の観察（眼の充血）

区分：状況設定／分類：弱い関連／主題：NPPVと眼／出典：午後問題PDF 52ページ

> 【状況設定文】A さん（37歳、男性）は妻（40歳、会社員）と2人暮らし。筋強直性ジストロフィーで週5回の訪問介護を利用していた。1か月前に傾眠傾向が著明となり入院して精査した結果、睡眠時無呼吸に対して夜間のみフェイスマスクを用いた非侵襲的陽圧換気療法が導入された。A さんは四肢遠位筋に筋萎縮と筋力低下があるが、室内の移動は電動車椅子を操作して自力で行え、食事も準備すれば妻と同じものを摂取できる。退院後、週1回午後に訪問看護が導入されることになった。

退院前カンファレンスで、訪問介護の担当者から、これまでと同様に退院後も昼食の準備と後始末、口腔ケア、入浴介助を行う予定と発言があった。訪問看護師は訪問介護の担当者に、A さんの状態の変化に気付いたら連絡がほしいと協力を求めた。訪問介護の担当者に説明するA さんの状態の変化で、特に注意が必要なのはどれか。

1　傾眠傾向
2　眼の充血
3　口腔内の乾燥
4　食事摂取量の低下

### 解説

| 選択肢 | 判定 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 正答 | 傾眠・頭痛・朝の倦怠感はCO2ナルコーシスの前兆で、早急な連絡が必要。 |
| 2 | 誤答 | 眼の充血はマスクから漏れた空気が眼に当たる刺激や結膜乾燥で起こり、マスクの調整で対応する。生命に関わる変化ではない。 |
| 3 | 誤答 | 口腔内乾燥はNPPVでよくある不快症状で加湿で対応する。 |
| 4 | 誤答 | 食事摂取量の低下は重要だが、この疾患・状況では換気の変化が最優先。 |

**公式正答：1　傾眠傾向**

**ポイント**：NPPVマスクのリークが眼に向くと結膜充血・ドライアイ・角膜障害の原因になるため、フィッティングを確認する。